

# **Dermatologie**

## **Diagnostic des lésions élémentaires**

Prof. Michaël Hofer

Unité d'Immuno-allergologie et rhumatologie

Service de Pédiatrie

CHUV, Lausanne

# Pourquoi l'examen de la peau est-il important ?

=> la peau est un organe qu'on peut entièrement observer = regarder partout, même si la lésion est sur la main ! Indique

1. Piste étiologique maladies de la peau, systémiques ou infectieuses

2. Diagnostic dépend d'un bon examen

- Pathologie cutanée
- Pathologie cutanée ou d'autres organes

3. Lésions évoluent dans le temps

= bien les décrire au départ, car l'évolution peut aider à poser le diagnostic

# Démarche diagnostique en dermatologie

## 1. Analyse des lésions élémentaires

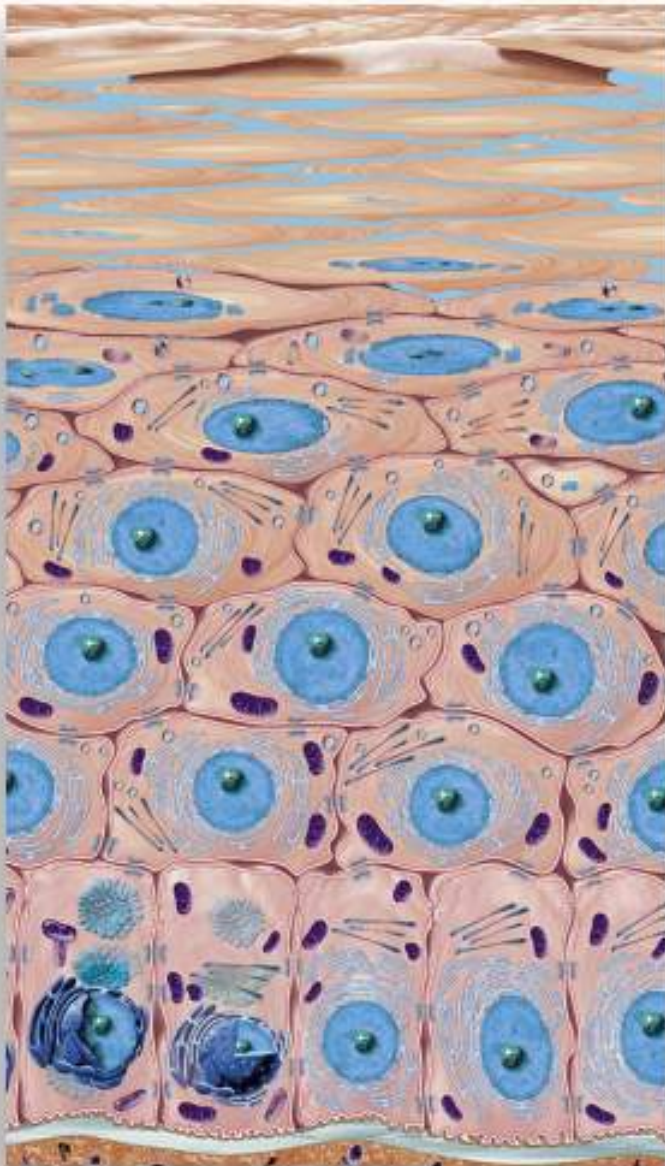
- Primaires: processus pathologique initial
- Secondaires: évolution du processus pathologique initial

Prendre  
de  
bonnes  
photos

## 2. Groupement

## 3. Topographie

# Epiderme



Stratum corneum

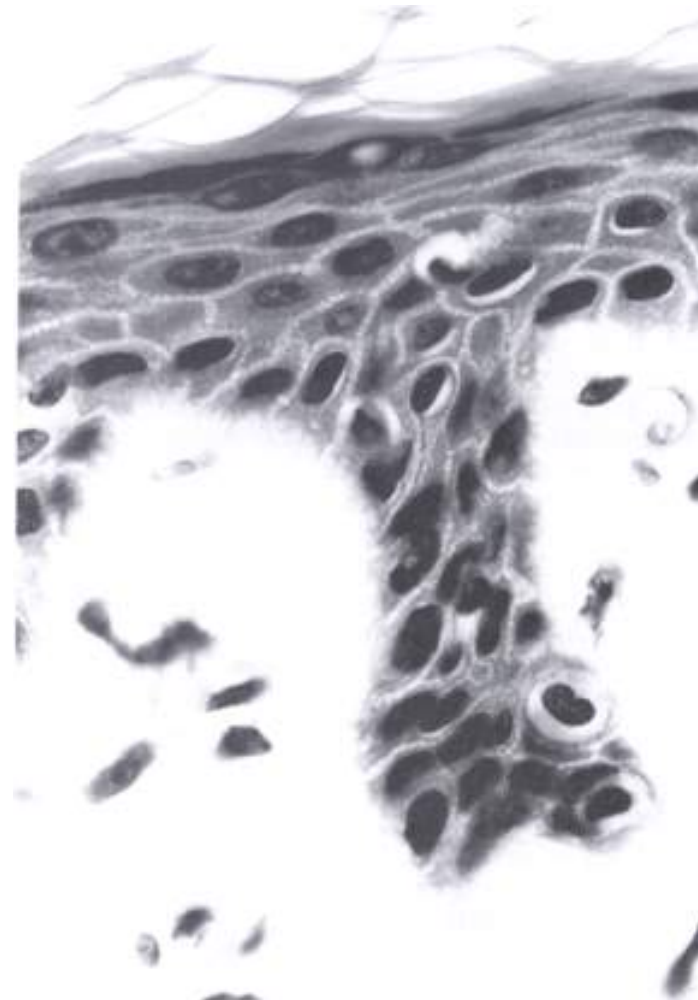
Stratum lucidum

Stratum granulosum

Stratum spinosum

Stratum basale

Basalmembran

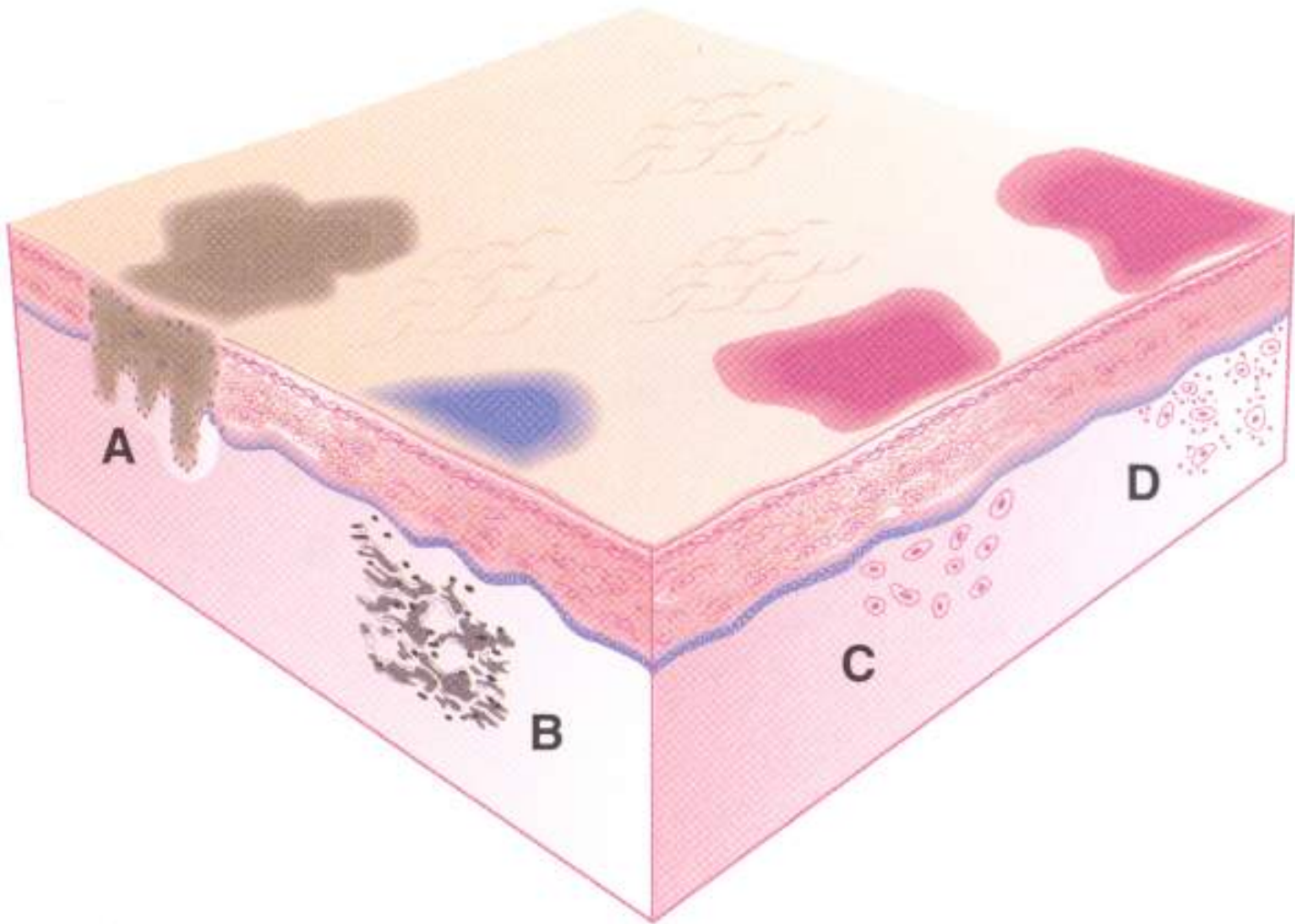


# Lésions élémentaires primaires

# Macule

- Tache colorée sans relief = on la voit, mais on ne la palpe pas à l'examen
- Couleur:
  - Rouge: érythème, purpura
  - Blanc: dépigmentée
  - Brun: hyperpigmentée

Test de la vitropression : si elle disparaît, on a une lésion intra-vasculaire, alors que si elle ne disparaît pas, on a une lésion extra-vasculaire





Purpura: ne disparaît pas à la vitropression





# Purpura: étiologie

(ou pétéchie)

Hémorragie intra-dermique

Purpura fébrile de l'enfant !!!

(plus grave)

## 1. Purpura vasculaire

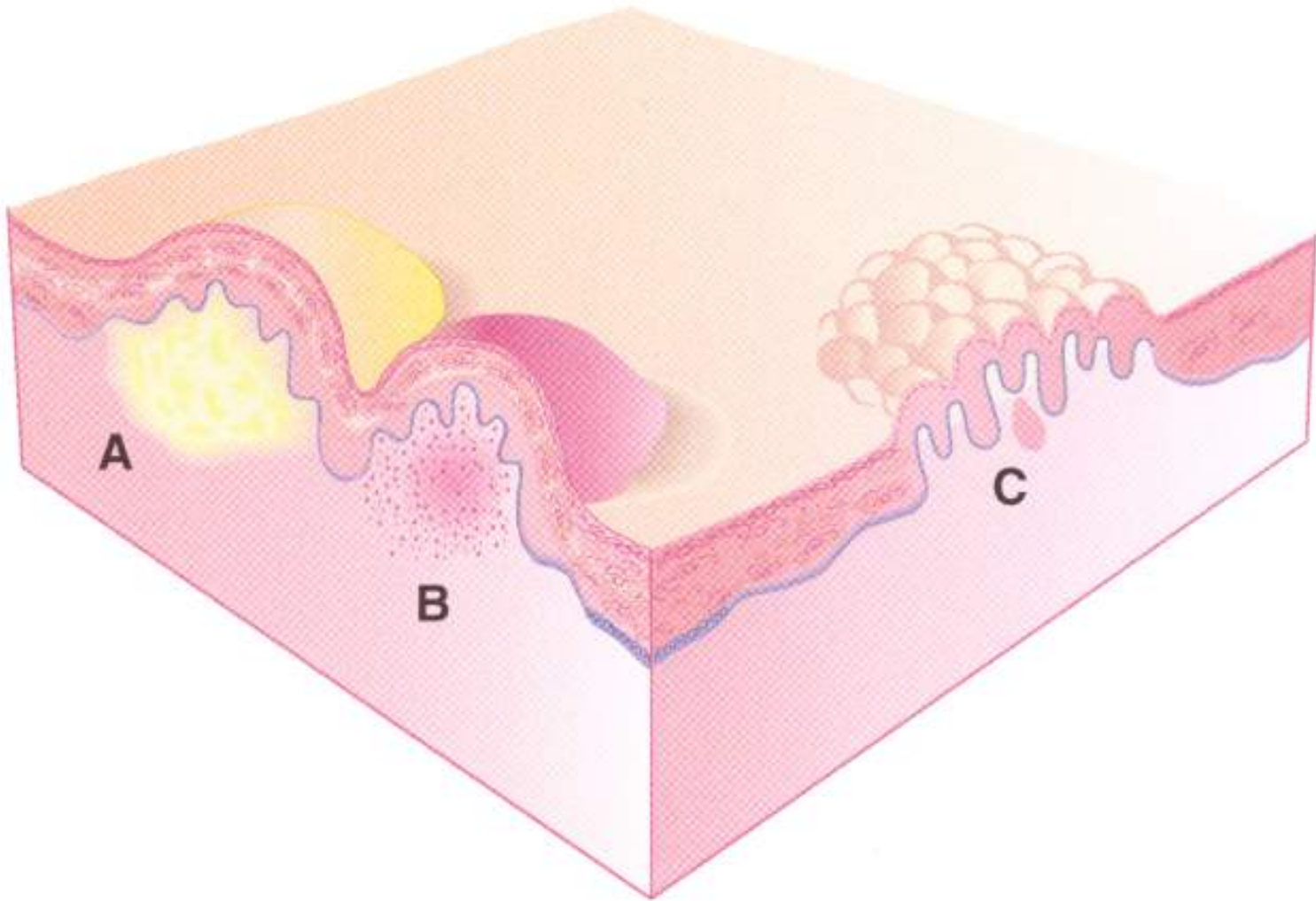
- Fragilité vasculaire
- Vasculite, infectieux, allergique = inflammation

## 2. Purpura plaquettaire

- Déficit quantitatif (ex. : anémie)
- Déficit qualitatif

=> il vient des méningocoques, donnant une infection très rapide et sévère, la peau ayant des pétéchie comme signe => dans ce cas, on donne des antibiotiques sans même faire de culture !

**Papule** => peut être le début d'une tumeur cutanée !

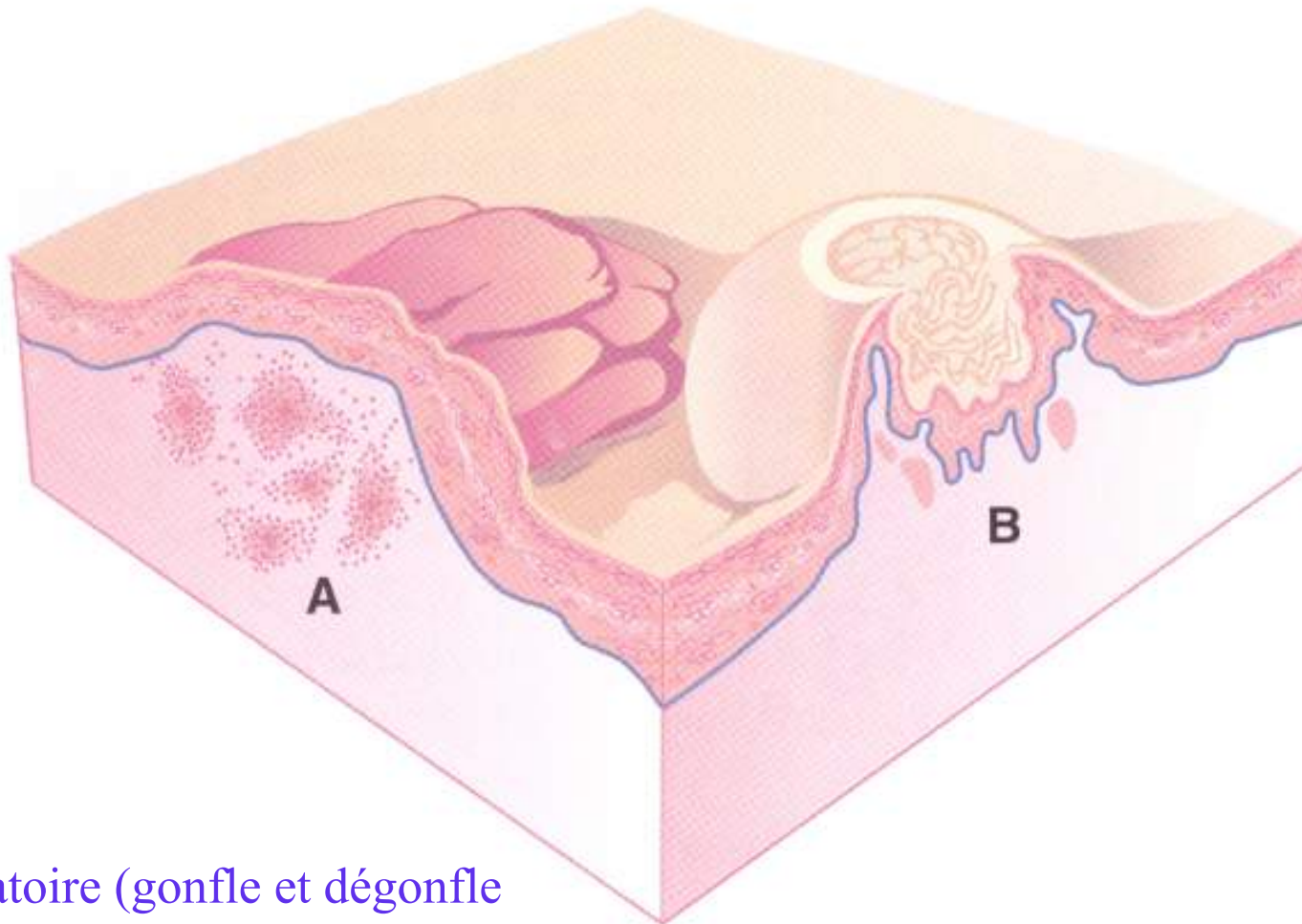


# Papule

- Lésion sur-élevée solide par augmentation focale de masse du tissu
- $< 0.5$  cm
- Distinction:
  - Epidermique: limites nettes = superficie
  - Dermique: limites moins nettes = profondeur
    - Par œdème: urticaire
    - Par infiltrat dermique inflammatoire ou tumoral

# Nodule > 0.5 cm

= une papule, mais juste plus épaisse

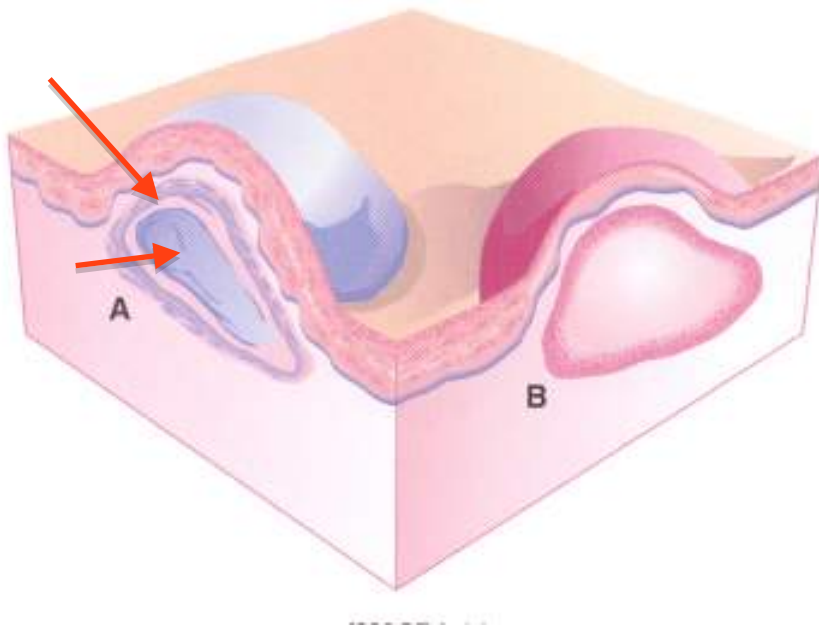


Inflammatoire (gonfle et dégonfle très vite), tumoral, etc.

# Kyste

Toutes les lésions précédentes étaient pleines et maintenant on a un centre semi-liquide, avec ici un morceau du derme entre la peau et le bas, à différencier d'une vésicule (décollement de la peau !) !

- Lésion semi-solide « fluctuante » à la palpation



A.



B.



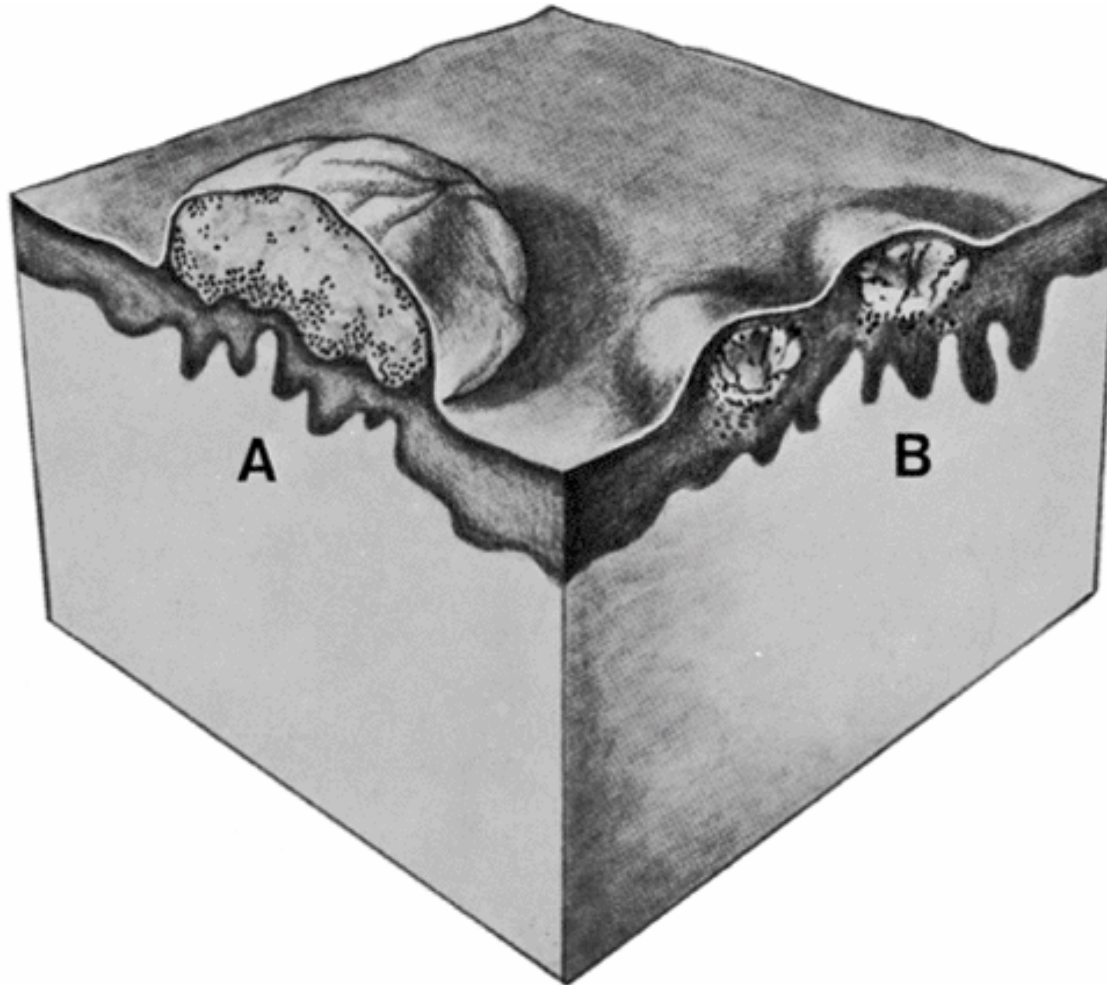
**Vésicule** = détachement de la peau



Elles  
peuvent  
être  
isolées  
ou en  
bouquet,  
à  
préciser

# Vésicule et bulle

Vésicule  $< 0,5\text{cm}$  et bulle  $> 0,5\text{cm}$

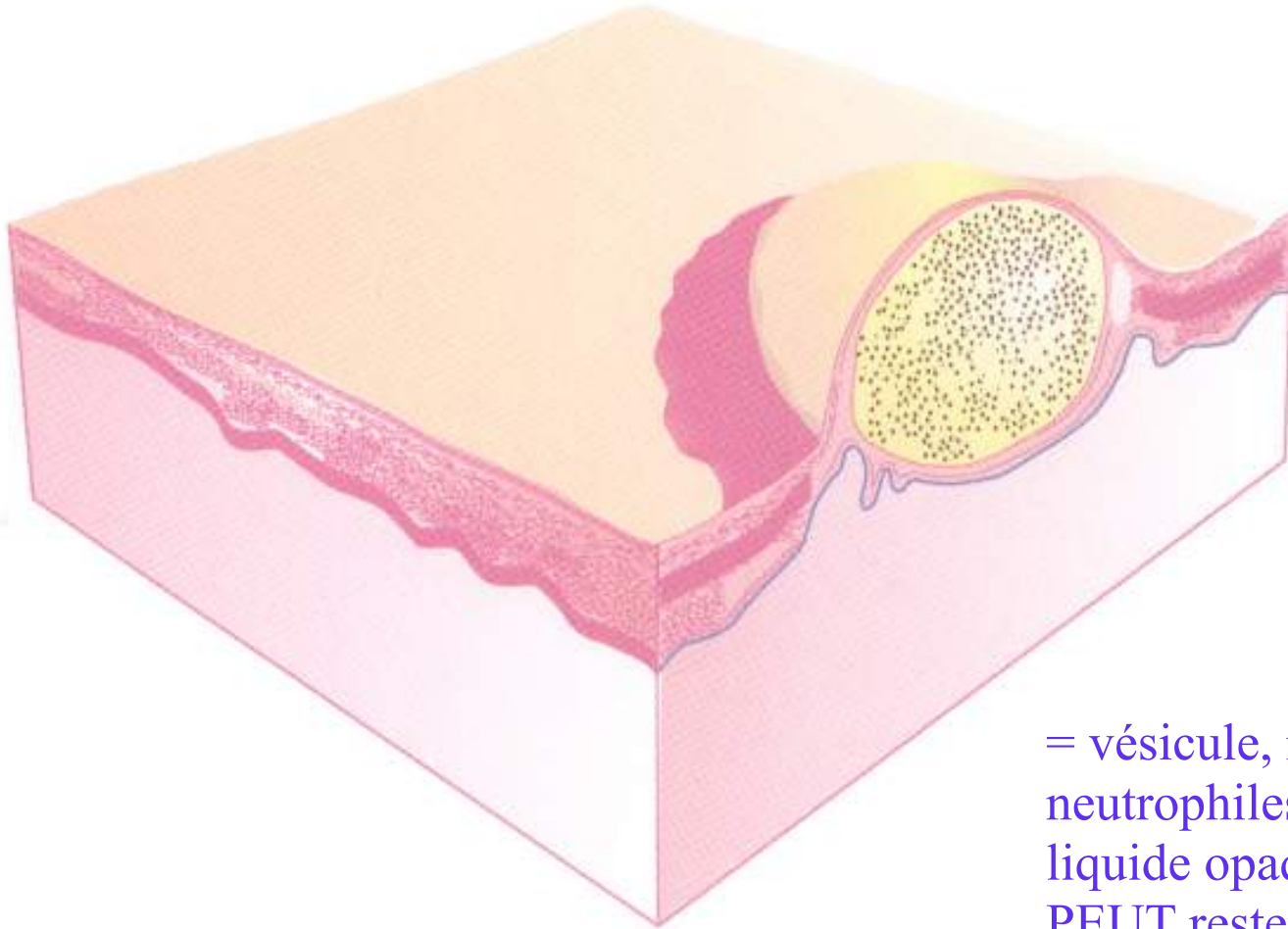




# Vésicule et bulle

- Soulèvement circonscrit de l'épiderme contenant un liquide clair ou hémorragique
  - Vésicules  $< 0.5$  cm
  - Bulles  $> 0.5$  cm
    - Intraépidermiques: fragiles = dans l'épiderme
    - Sous épidermiques: solides = entre l'épiderme et le derme

# Pustule



= vésicule, mais avec des  
neutrophiles dedans =  
liquide opaque, mais qui  
PEUT rester stérile !

# Pustule

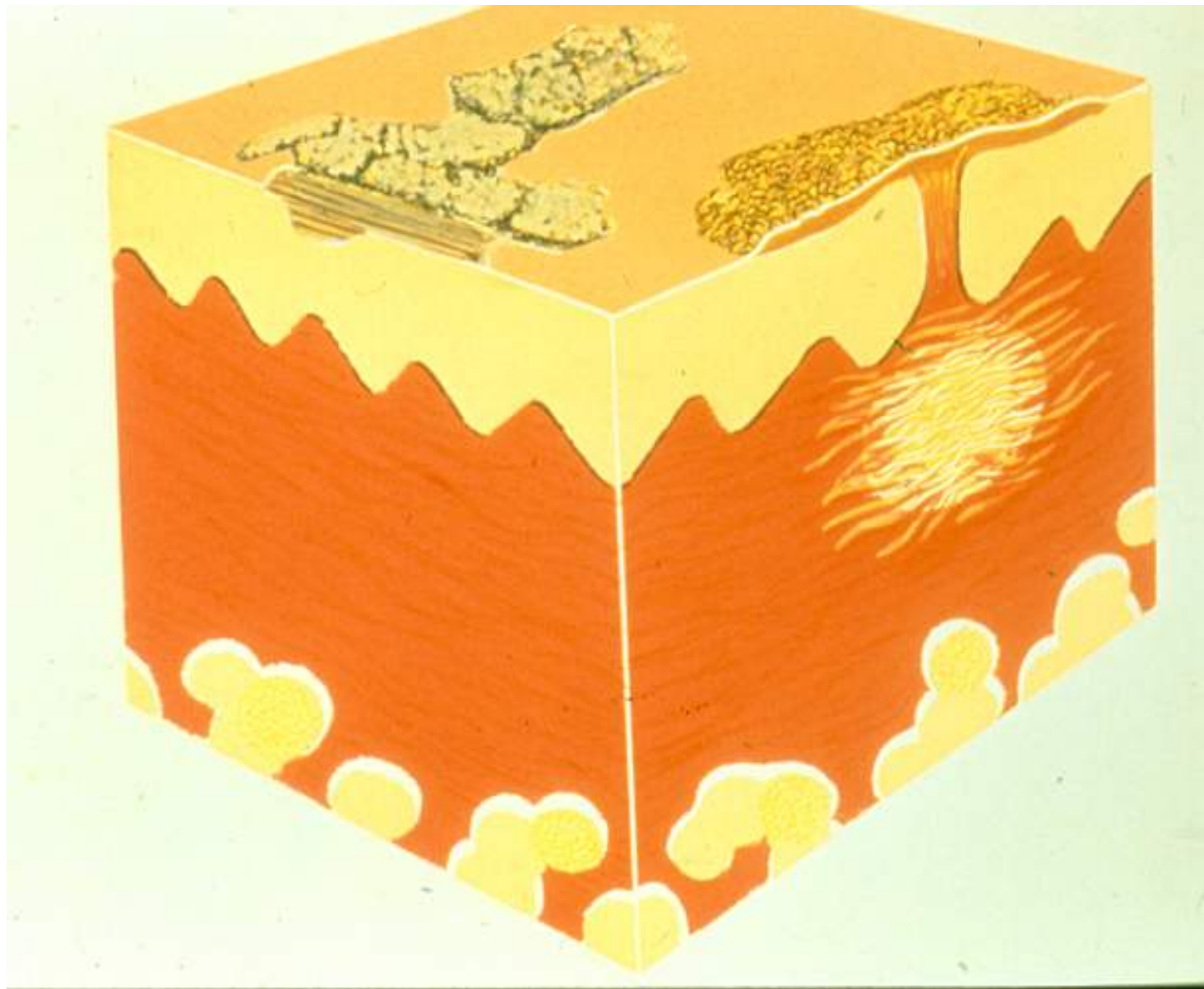
- Lésion circonscrite contenant du pus
  - Folliculaire: centrée par un poil
  - Non folliculaire

# Lésions élémentaires secondaires

# Croûte

- Coagulation à la surface de la peau d'un exsudat:
  - Séreux: à partir de vésicule
  - Purulent: à partir de pustule
  - Hématique: à partir de plaie

(Couleur jaune = mélassérique)

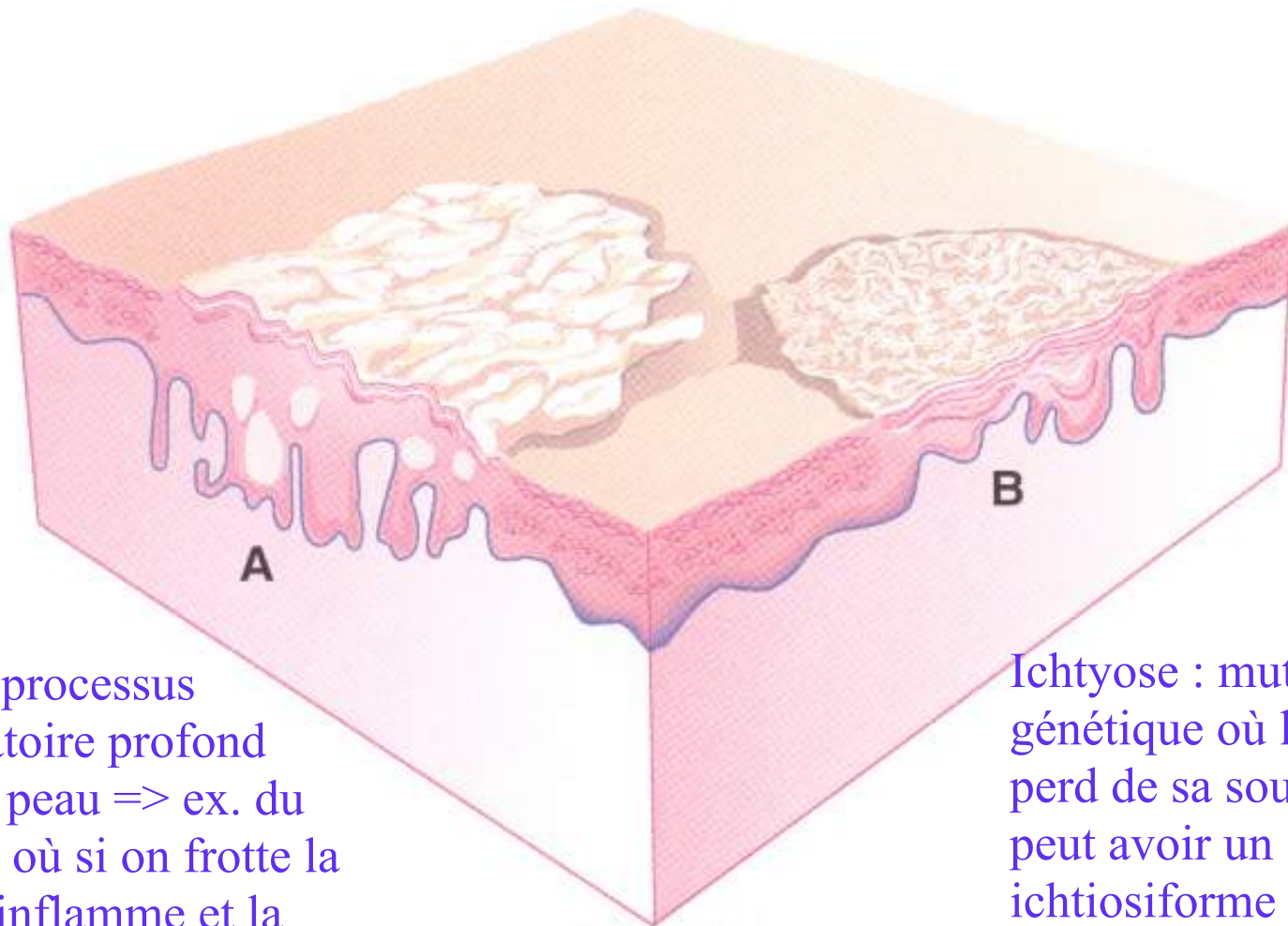




# Squame

- Lames de couches cornées qui se détachent de la peau => laisse le derme visible !
- L'aspect de la squame est spécifique du processus pathologique: = dépend de la taille et l'aspect
  - Psoriasiforme
  - Ichtyosiforme
  - Scarlatiniforme
  - Pityriasiforme => petits squames

# Squame



En A, un processus inflammatoire profond touche la peau => ex. du psoriasis, où si on frotte la peau, on inflamme et la peau se détache

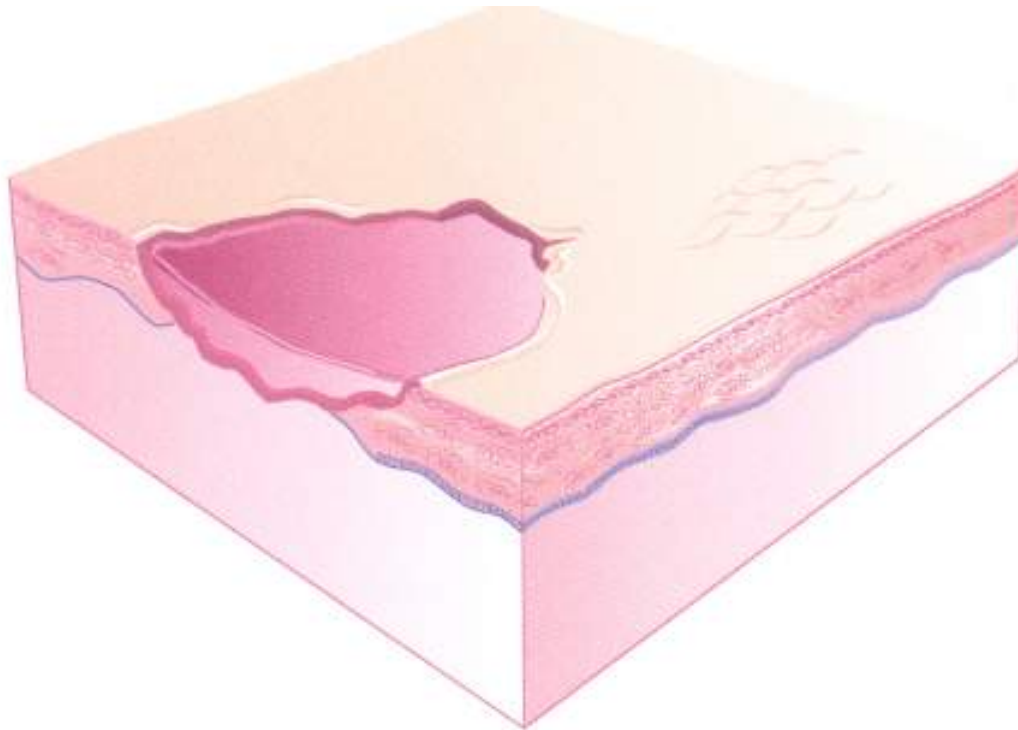
Ichtyose : mutation génétique où la peau perd de sa souplesse. On peut avoir un ichtiosiforme en cas d'eczéma chronique

Pertes ou augmentation  
de substance

(Les escarres en sont)

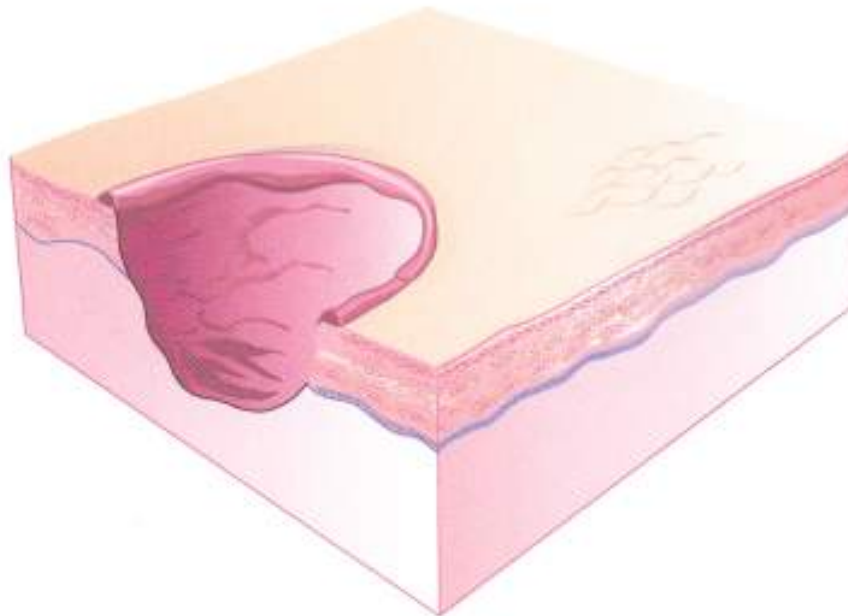
# Erosion: superficielle

- Perte plus ou moins importante de l'épiderme
- Guérison sans cicatrice => une lésion plus profonde donnerait une cicatrice



# Ulcère: profond

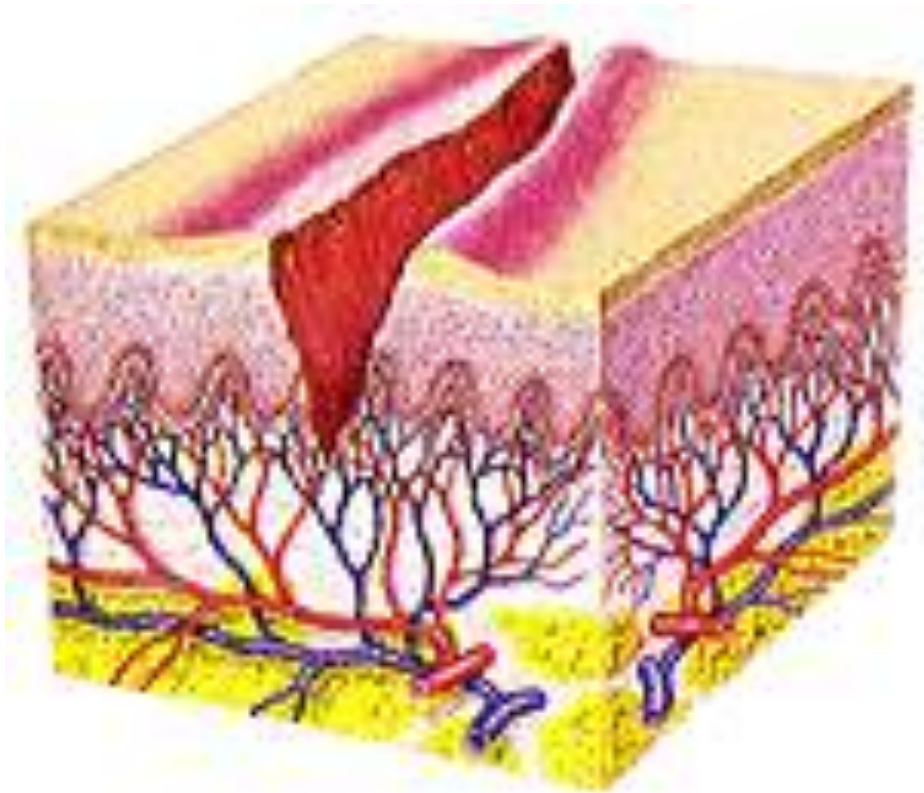
- Perte de substance s'étendant au derme
- Résulte d'un traumatisme ou d'une nécrose
- Guérison avec formation d'une cicatrice



Ulcère : vient souvent d'une mauvaise irrigation de la peau, où la peau n'arrive plus à se régénérer. Arrive souvent dans les pathologies où la perfusion périphérique est diminuée

# Rhagade (fissure): linéaire

Contrairement à avant, on a une perte de substance linéaire, souvent à cause du froid ou à cause du travail très manuel

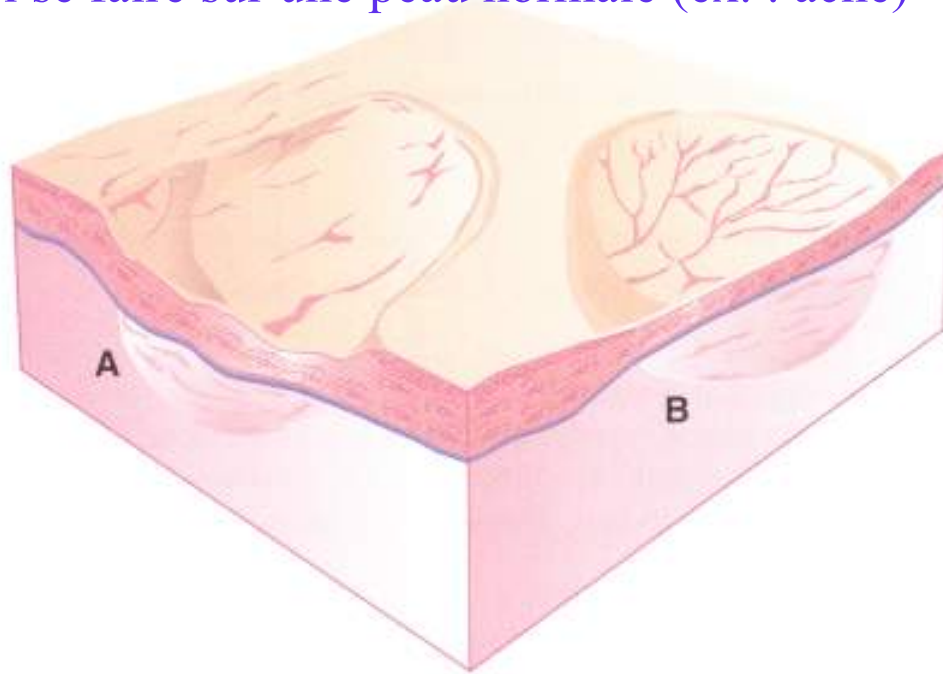


# Atrophie

Perte de substance avec épiderme normal ou cicatrisé

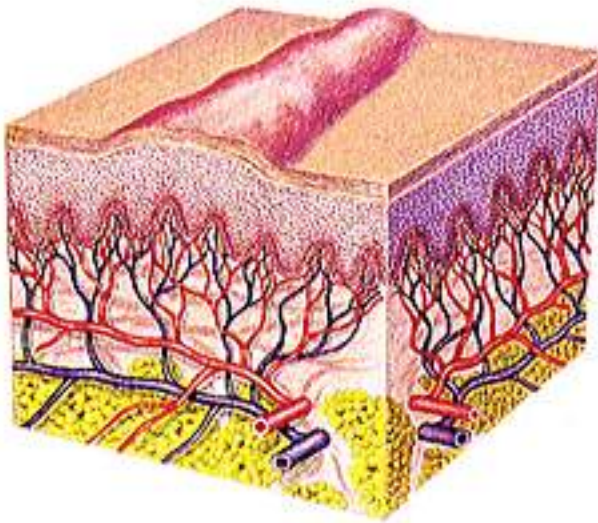
Ex. : de la cortisone qui touche une plaie en guérison peut former ce trou !

Cela peut aussi se faire sur une peau normale (ex. : acné)





# Cicatrice hypertrophique



# Sclérose

= rend la peau beaucoup moins souple que normalement. Elle paraît dure et ‘brille’

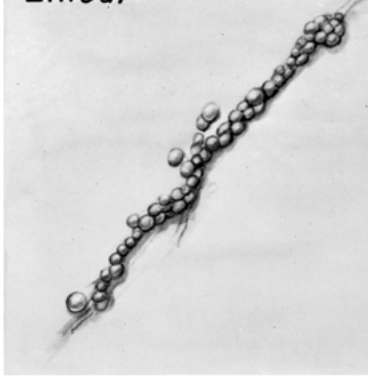
Développement anormal du tissu conjonctif avec augmentation de volume.

Dans la peau

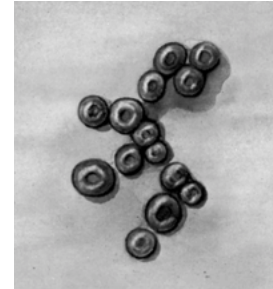
Dans les organes internes (comme l'oesophage)

La sclérose se retrouve sur la peau, mais aussi partout sur les tissus de soutien ou certaines organes comme l'oesophage

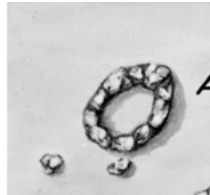
# Groupement des lésions



Linéaire



En bouquet  
(typique de l'Herpès)



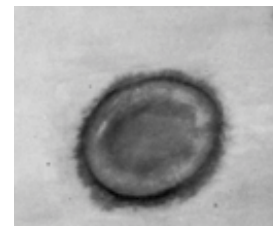
Annulaire



Dermatome,  
Métamérique



Polycyclique

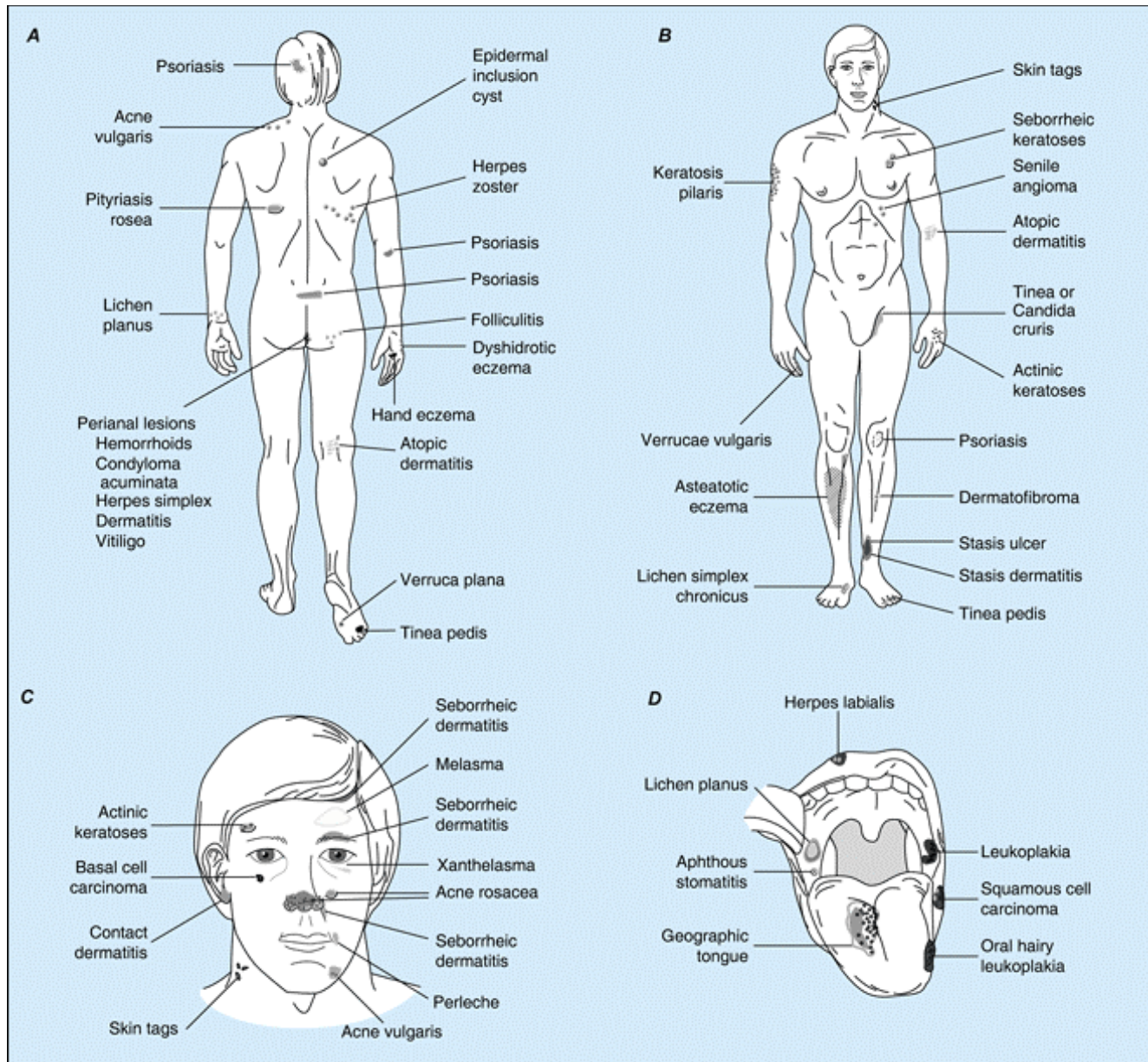


Nummulaire



Arciforme

# Topographie des lésions



Ex. de la rougeole ou de la varicelle, qui apparaissent à certains endroit puis se déplacent

# **Dermatologie**

## **Diagnostic des lésions élémentaires**

- Examen complet de la peau
- Bonne description des lésions
- Documenter: photos
- Description de l'évolution des lésions
- Essentiel pour le diagnostic:
  - Maladie cutanée
  - Maladie systémique